SDD 327 Sujet n°1

Spécialité : Cancérologie - Urologie

Date : 08/11/2023
Auteur : VERNEY Charles
Relecteur(s) : ELAYLI Robin, Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Annonce
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	- ITEM 1 : Relation médecin patient - ITEM 291 : Cancérogénèse, oncogénétique - ITEM 292 : Diagnostic des cancers - ITEM 294 : Traitement des cancers - ITEM 295 : Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer - ITEM 310 : Cancer de la prostate - ITEM 347 : Rétention aiguë d'urine
Situation(s) de départ en lien avec la station	- SDD 97 Rétention aiguë d'urine - SDD 327 Annonce de diagnostic de maladie grave
Matériel nécessaire à la station	
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes docteur junior en urologie et vous recevez pour la première fois la fille/le fils de Mr Globe hospitalisé depuis deux semaines. Sa fille/son fils est d'ailleurs titulaire de sa curatelle car le patient de 85 ans souffre d'une démence vasculaire (MMS à 20 au dernier bilan à l'EHPAD).

Son père a été admis aux urgences depuis son EHPAD pour un globe vésical avec impossibilité de sondage vésical. Il a donc eu recours à vos services car votre collègue a dérivé les urines grâce à un cathéter sus-pubien avant de l'hospitaliser en urologie. Il a par la suite été diagnostiqué par biologie (PSA à 5397 ng/mL) imagerie (scanner) puis biopsie (transrectale, échoguidée) un adénocarcinome Gleason 9 avec probables métastases osseuses ostéo-condensantes. Le dossier a été discuté en RCP hier et une surveillance simple, sans traitement a été décidée. Le patient devrait pouvoir sortir en EHPAD dans quelques jours, maintenant que les soins pour le cathéter sus-pubien sont organisés.

L'infirmier qui l'a accueilli vous a expliqué que la fille/le fils revient de vacances et n'a pas pu être tenu.e au courant de ces évènements car l'EHPAD n'avait pas son nouveau numéro de portable.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Réaliser l'annonce diagnostique
- Expliquer la prise en charge et les modalités
- Répondre aux questions du patient

Vous ne devez pas :

- Réaliser un examen clinique
- Réaliser une ordonnance
- Réaliser un interrogatoire

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
Présentation et prise de connaissance du contexte		
1.	Demande ce que la fille/le fils sait de la situation	*1 pt*
Explication du diagnostic		
2.	Explique la rétention aiguë d'urine avec des mots simples : exemple d'explication *urine retenue dans la vessie par un obstacle mécanique*	1pt
3.	Explique que le sondage vésical simple a échoué avec des mots simples : exemple d'explication *Le médecin a essayé de soulager votre père par un tuyau pour aider à l'écoulement des urines en passant par les voies naturelles mais le tuyau n'a pas fonctionné*	1 pt
4.	Explique la nécessité du cathéter sus-pubien avec des mots simples : exemple d'explication *Un tuyau a été installé pour aider à l'écoulement des urines en passant directement à la vessie sans aller dans voies naturelles d'écoulement*	1 pt
5.	Explique en termes simples qu'une imagerie à été faite pour rechercher l'obstacle ayant entraîné ce globe urinaire et qu'elle a identifié une atteinte de la prostate	1 pt
7.	Explique en termes simples que des examens ont confirmé le cancer de prostate	1 pt
8.	Utilise le mot cancer seulement après avoir expliqué l'ensemble de la situation ayant amené à son diagnostic OU ne l'utilise pas dans la première minute de dialogue	1 pt
9.	Explique que des métastases ont été identifiées au niveau des os	1 pt
10.	Explique que les métastases correspondent à des cellules cancéreuses qui ont migré	1 pt
Explique la suite de la prise en charge		
11.	Explique clairement qu'il n'y aura pas de chimiothérapie ou d'opération	1 pt
12.	Justifie la décision par : - l'âge du père - la notion de confort - la lenteur de progression de ce type de cancer	1 pt

13.	Explique qu'il y aura malgré tout : - un suivi - des traitements contre la douleur - une radiothérapie possible pour les douleurs osseuses	1 pt
Accompagnement et soutien		
14.	Propose une prise en charge psychologique à la famille	1 pt
15.	Propose un entretien ultérieur	1 pt
	1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair	

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

TOTAL (max 20 items)	**X points**

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

Dans cette partie vous pouvez indiquer des éléments qui vous semblent importants à signaler aux étudiants qui s'entraînent sur votre station (Élément inacceptable, comment raisonner face à votre station, autre conseil…).

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes la fille/ le fils de Mr Globe, 85ans, résident en EHPAD et atteint d'une démence importante. Vous êtes d'ailleurs son responsable légal en qualité de curateur.ice. Vous revenez de 2 semaines de vacances et venez d'apprendre en passant à l'EHPAD que votre père a été hospitalisé en urgence en urologie pour un problème de rétention d'urine. Vous n'avez pas été tenu au courant car vous veniez de changer de numéro de téléphone. Vous êtes inquièt.e pour la santé de votre père qui malgré sa démence fait preuve de sa gentillesse et de sa douceur de toujours à chacune de vos visites hebdomadaires. Vous rencontrez le/la jeune médecin en charge de votre père.
Il/elle doit vous expliquer la situation, le diagnostic de cancer de prostate probablement métastatique, la mise en place d'un cathéter sus-pubien de manière définitive et l'absence de thérapeutique curative proposée pour ce cancer, avec surveillance simple.

Plan de la station ECOS :

Ou se positionne le patient simulé ?

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Identité du patient :

Mode de vie :

Comportement global :

Vous ne devez pas exprimer d'agressivité auprès du/de la médecin, mais plutôt une incompréhension si les rapports bénéfices risque de l'abstention thérapeutique et de la surveillance simple du cancer de prostate ne sont pas clairement exprimés.

Vous êtes très affligé.e par cette nouvelle,

Antécédents personnels :

Antécédents familiaux :

Médicaments :

Bien distinguer le traitement de fond (= habituels) des traitements pris récemment dans le cadre de la situation clinique (ex prise de PARACETAMOL pour soulager les douleurs)

Questions à poser si les informations ne sont pas spontanément données :

- « Pourquoi a-t-il été hospitalisé ? »
- « Qu'est-ce qui a causé cette rétention d'urine ? »
- « Ce cancer va-t-il le tuer ? »
- « Pourquoi ne voulez-vous pas mettre de traitement ? »
- « Il va aller en soins palliatifs ? »

Vous devez exprimer un besoin d'aide psychologique si ce n'est pas proposé spontanément : « Comment vais-je faire sans lui ? Je me sens anéanti… pourrais-je voir quelqu'un ? »

Constantes :